BC3 – Chapitre 4 : tout ce qu'il faut savoir

Pratiques et comportements alimentaires – fiche complète (à jour au 1er novembre 2026)

Mode d'emploi

Cette fiche résume tout le chapitre 4 : rôles de l'acte alimentaire, besoin et oralité, régulation et dérégulations, déterminants, évolution des pratiques, pratiques actuelles (végétarisme, régimes à la mode), accompagnement, rythmes, enfant, âges de la vie, mesure, alimentation durable, TCA, précarité, religions, analyse sensorielle, cultures culinaires, fil rouge, approfondissements et méthodes d'oral. Elle suit l'ordre du cours (4.3.1 à 4.8).

Erreurs corrigées (le cours les signale pour le fascicule du CNED, à retenir sous leur forme juste) :

- **Groupes d'aliments** : la table **Ciqual 2025 (ANSES)** compte **11 groupes et plus de 60 sous-groupes**, et non « 10 groupes et 32 sous-groupes ». Pour l'éducation, on utilise les **repères de Santé publique France (2019)**.
- **Part de l'alimentation dans les dépenses** : l'étude Insee de 2006 est dépassée. En **2025**, aliments et boissons non alcoolisées = **12,5 %** de la dépense de consommation des ménages (**Insee, 29 mai 2026**). La série historique **35 % (1960) → 20 % (2014)** (Insee Première n° 1568, 2015) porte sur un champ plus large (avec boissons alcoolisées et repas hors domicile) : ne pas comparer directement les deux chiffres.
- **Dopamine et sérotonine** sont des **neurotransmetteurs**, pas des hormones.
- **Grande distribution** : premier libre-service en France en **1948** (et non 1950) ; premier hypermarché **1963** ; **loi Royer 1973** ; crise de la **vache folle 1996**.
- **Wresinski (1987)** parle d'« **obligations professionnelles, familiales et sociales** », pas de « responsabilités élémentaires ».
- **Aide alimentaire européenne** : **PEAD 1987 → FEAD 2014-2020 → FSE+ 2021-2027**.
- **Pauvreté et obésité** : ne pas dire que la nourriture est une « récompense » des « classes défavorisées » (stigmatisant). Le lien vient des **prix, de l'offre, du temps, du stress, de l'environnement** : ce sont des **inégalités sociales de santé**.
- **Lait maternel** : son sucre est le **lactose** (glucose + galactose). Les arômes de l'alimentation de la mère passent dans le **liquide amniotique** (pas de « barrière plasmatique »).
- **Personne âgée** : l'âge de la retraite n'est pas une définition. On retient **60 ou 65 ans** selon les sources (OMS, Insee) et **70 ans pour la dénutrition (HAS et FFAMCO, 2021)**.

Ce qui est en **gras** est à savoir par cœur. Une référence se cite **auteur + année** et se **relie au public et à l'action**.

1. Les rôles de l'acte alimentaire (4.3.1)

Manger remplit **6 rôles**, toujours présents ensemble :

Rôle	Ce que cela veut dire	Exemple
Biologique	Couvrir les besoins en énergie, eau, nutriments	Boisson de récupération après un match
Hédonique	Plaisir (goût, odeur, texture) ; il **participe à la régulation** et à l'adhésion aux conseils	Le dessert préféré
Psychologique	Réconfort, sécurité, souvenirs (« madeleine de Proust »), émotions	Chocolat après une rupture
Social	Créer du lien, partager, structurer le temps familial	Repas de Noël
Culturel et identitaire	Dire à quel groupe on appartient (région, pays, religion, génération)	Couscous du dimanche chez la grand-mère
Économique	Le budget, le prix, les promotions orientent les choix	Produit en promotion

Le repas gastronomique des Français est inscrit au **patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2010** : il illustre la dimension culturelle et sociale. Le CNED présente aussi trois **points de vue** : alimentaire (les aliments), santé, socio-économique.

Leçon pour l'action : un conseil qui ne vise que le rôle biologique est rarement suivi. Le plaisir est un levier, pas un ennemi.

2. Le comportement alimentaire : besoin, oralité, pulsion (4.3.2)

- **Comportement alimentaire** : ensemble des conduites vis-à-vis de l'alimentation (**choix, prises, rythmes, quantités, contexte**).
- **Besoin** : nécessité physiologique d'énergie, d'eau et de nutriments. **Envie** : désir d'un aliment précis, sans besoin. **Pulsion** : poussée interne peu contrôlée vers la prise (système de récompense, **dopamine**).
- **Oralité** (Abadie) : ensemble des fonctions de la bouche (**succion, déglutition, mastication, goût, langage**). Elle se construit de la **vie fœtale** (succion dès le fœtus) à l'enfance : oralité primaire (réflexe, succion), puis oralité secondaire (volontaire, cuillère, morceaux, mastication). Certains enfants ont des **troubles de l'oralité** → prise en charge spécialisée (orthophoniste).
- **ARFID** (DSM-5, **2013**) : trouble de restriction ou d'évitement de l'ingestion des aliments, **sans préoccupation pour le poids** (sensoriel, peur d'avaler, manque d'intérêt), avec conséquences (perte de poids, cassure de courbe, carences). À distinguer de la **sélectivité** du jeune enfant, fréquente et transitoire.

3. Régulation et dérégulations (4.3.3)

Faim, rassasiement, satiété

Notion	Moment	Mécanismes
Faim	**Avant** le repas	Sensation qui pousse à manger ; creux gastrique ; **ghréline** (estomac, orexigène)
Rassasiement	**Pendant** le repas, conduit à l'**arrêter**	Distension gastrique, **CCK** (cholécystokinine), **rassasiement sensoriel spécifique**
Satiété	**Après** le repas, **jusqu'au suivant**	**GLP-1, PYY**, insuline ; à long terme **leptine** (tissu adipeux, reflète les réserves)

- **Rassasiement sensoriel spécifique** : le plaisir baisse pour l'aliment consommé, pas pour les autres → explique qu'il reste « de la place pour le dessert » et l'intérêt de la **variété**.
- **Cascade de satiété (Blundell, 1987)** : facteurs sensoriels, cognitifs, post-ingestifs puis post-absorptifs, du début du repas aux heures suivantes.
- **Indice de satiété (Holt et coll., 1995)** : portions de 240 kcal, pain blanc = 100 ; **pomme de terre bouillie 323**, poisson 225, porridge 209, orange 202, pomme 197, **croissant 47** (323 / 47 ≈ 7 fois plus rassasiant). Eau, fibres, protéines rassasient ; sec, gras, sucré peu.
- **Densité énergétique** (kcal pour 100 g ; travaux de **Barbara Rolls**) : on mange un volume assez stable ; baisser la densité d'un repas baisse l'énergie sans augmenter la faim.
- **Deux systèmes** : **homéostatique** (hypothalamus, équilibre énergétique, « manger pour vivre ») et **hédonique** (récompense, dopamine, « manger pour le plaisir »). S'y ajoutent les **facteurs cognitifs** (règles, connaissances, attention) et **environnementaux** (portions, écrans, présence d'autres, émotions).
- **Échelle de la faim (0 à 10)** (fiche O4.2) : 0 très faim, 2 faim nette (bon moment pour manger), 5 ni faim ni rassasié, **7 rassasié (bon moment pour s'arrêter)**, 9 trop mangé, 10 malaise. Zone de confort ≈ **3 à 7**.
- **Sommeil et écrans** : **Spiegel 2004** (sommeil réduit : leptine −18 %, ghréline +28 %, faim +24 %) ; **Robinson 2013** (manger devant un écran augmente la prise au repas et plus tard). **National Sleep Foundation 2015** : **9-11 h** de 6 à 13 ans, **8-10 h** de 14 à 17 ans, **7-9 h** de 18 à 64 ans. Manger vite = moins de temps pour le rassasiement → au moins **20 à 30 minutes assis** à la cantine.

Les dérégulations

- **Restriction cognitive (Herman et Polivy, 1975)** : contrôler son alimentation par des **règles mentales** au lieu des sensations. **Cercle vicieux** en 6 étapes : **insatisfaction corporelle → restriction → frustration, faim, envies → perte de contrôle (craquage) → culpabilité, baisse de l'estime de soi → reprise de poids, nouveaux régimes** (effet yo-yo). Restriction **rigide** (délétère) ≠ **flexible** (moins délétère).
- **Externalité (Schachter, 1968)** : manger selon des **signaux extérieurs** (heure, vue, odeur, portion) ; expérience de l'**horloge truquée**.

- **Alimentation émotionnelle** (Bruch) : manger en réponse aux émotions (ennui, stress, tristesse).
- **DEBQ (van Strien, 1986)** : mesure 3 styles, **restreint, émotionnel, externe**. **TFEQ (Stunkard et Messick, 1985)** : restriction, désinhibition, faim.
- **Grignotage** : prises sans faim, hors repas, souvent devant un écran ≠ **collation** (prévue, répond à une faim).
- **« Addiction alimentaire »** : la **Yale Food Addiction Scale (Gearhardt, 2009)** est un outil de recherche, **pas un diagnostic du DSM**.

4. Les déterminants du comportement alimentaire (4.3.4)

Six familles qui agissent en même temps :

- **Individuelles** : **biologiques et sensoriels** (goût inné du sucré, âge, santé) ; **psychologiques** (émotions, stress, apprentissages, image du corps) ; **cognitifs** (connaissances, croyances, littératie).
- **Collectives** : **sociaux et culturels** (famille, pairs, normes, religion, genre) ; **économiques** (revenus, prix, budget) ; **environnementaux** (offre, portions, marketing, temps, équipement).

Une action qui ne vise que les connaissances agit sur **1 famille sur 6** : l'information seule change peu les comportements.

- **Environnement obésogène** : environnement qui favorise l'excès d'apports et la sédentarité (**grandes portions, offre abondante d'aliments très palatables, marketing omniprésent**).
- **Taille des portions (Rolls, 2002)** : portions de 500 à 1 000 g de macaronis → **environ +30 % d'énergie** avec la plus grande, **sans plus de rassasiement** ni compensation.
- **Modèle socio-écologique (Story et coll., 2008)**, **4 niveaux emboîtés** : **individuel** (goûts, compétences, motivation) ; **environnement social** (famille, amis, normes) ; **environnement physique** (offre à la maison, à l'école, au travail, au quartier ; prix ; portions) ; **macro-environnement** (politiques, marketing, systèmes de production, normes sociales). Il prolonge le modèle de Dahlgren et Whitehead (chapitre 2).
- **Temps, équipement, compétences culinaires** : un conseil qui demande un four ou une heure de cuisine échoue si la personne n'en a pas.
- **Société traditionnelle** (règles fortes, repas collectif, saisons) / **société moderne** : le **mangeur hypermoderne (Ascher, 2005)** doit sans cesse choisir avec des règles plus faibles (lien avec la **gastro-anomie de Fischler**).
- **Mythe** : croyance idéalisée (« la soupe fait grandir ») ; **rite** : manière d'agir répétée et réglée (apéritif, café, beurre salé en Bretagne). Respecter les rites avant d'écarter un aliment.
- **Industrie, distribution, médias** : produits très attirants, achat d'impulsion ; repères **1948, 1963, 1973, 1996** ; publicité (répétition, arguments pseudo-scientifiques, ciblage des enfants).
- **Genre (INCA 3, ANSES 2017 ; recueil 2014-2015)** : les hommes consomment plus de viande, charcuterie, alcool ; les femmes plus de fruits, légumes, laitages frais et déclarent plus souvent un régime. Les **hommes vivant seuls** mangent moins de fruits et légumes.
- **Catégorie sociale** : **PCS 2020** de l'Insee, **6 groupes** (agriculteurs exploitants ; artisans, commerçants et chefs d'entreprise ; cadres et professions intellectuelles supérieures ; professions intermédiaires ; employés ; ouvriers).
- **Loi d'Engel** : la part de l'alimentation dans le budget **baisse quand le revenu augmente**.

5. Évolution des pratiques et syncrétisme (4.3.5)

- **Modèle alimentaire français** : **3 repas** à heures fixes, **à table, en commun**, avec plaisir ; considéré comme **protecteur** (Fischler et Masson, 2008).
- **Part de l'alimentation dans la consommation des ménages : 35 % (1960) → 20 % (2014)** (Insee Première n° 1568, 2015) ; soit −15 points, −42,9 %. Explications : revenus qui montent plus vite (loi d'Engel), autres postes (logement, transport, loisirs), baisse relative des prix agricoles. **12,5 % en 2025** au sens strict (Insee, 2026).
- **Temps des repas** : **2 h 22 par jour** en 2010 (Insee Première n° 1417), un des plus élevés d'Europe.
- **Tendances** : hausse du **hors-foyer**, du **snacking**, des plats préparés, de la **livraison** ; individualisation ; **CNA, avis n° 90 (2022)** « Nouveaux comportements alimentaires ».
- **Syncrétisme culinaire** : **combinaison d'éléments de cultures culinaires différentes** (couscous aux légumes de saison français, pizza aux épices orientales), produit de la **mondialisation et des migrations**.
- **Sources de données** : INCA (ANSES), Esteban (SpF), Insee, Crédoc ; toujours noter l'**année du recueil**, qui n'est pas celle de la publication.

6. Les pratiques alimentaires actuelles (4.3.6)

Végétariens et flexitariens (Ifop pour FranceAgriMer, 2020, publié 2021)

- **≈ 2 %** sans viande (végétariens, pescétariens, végétaliens), 15-70 ans.
- **24 % de flexitariens** (réduction volontaire de la viande sans l'exclure) ; **8 %** limitent la viande sans se dire flexitariens.
- **68 %** pensent qu'on mange trop de viande en France. Avis du **HCSP (juin 2025)** : seuil maximal pour l'ensemble des viandes, seuils plus bas pour la viande rouge et la charcuterie.

Pratique	Exclut	Points de vigilance
Pescétarisme	Viande	Peu de risque
Végétarisme (lacto-ovo)	Viande et poisson	**Fer** (+ vitamine C, pas de thé au repas), oméga-3, zinc, iode
Végétalisme	Tous les produits animaux	**Vitamine B12 : supplément obligatoire** ; protéines, calcium, vitamine D, fer, iode, zinc, oméga-3
Véganisme	Mode de vie sans produit animal (cuir, laine…)	Idem végétalisme

- **Complémentarité des protéines** : associer **légumineuses + céréales** (dahl et riz, couscous et pois chiches).
- **Végétalisme de l'enfant** : déconseillé ou à encadrer de très près par les sociétés savantes (**GFHGNP, Lemale 2019** ; **Académie royale de médecine de Belgique, 2019**) ; suivi médical.

Régimes à la mode

- **Sans gluten** : indispensable en cas de **maladie cœliaque (≈ 1 %)** ; sans diagnostic, **pas de bénéfice démontré**, surcoût. Le déconseiller relève de la **prévention quaternaire** (éviter une sur-médicalisation).
- **Intolérance au lactose** : la plupart tolèrent **≈ 12 g de lactose** en une prise (**EFSA, 2010**), soit un bol de lait ; yaourts et fromages affinés passent souvent bien.
- **Jeûne intermittent (16:8)** : pas de supériorité à long terme sur une restriction classique (**Lowe 2020 ; Liu 2022**) ; contre-indiqué en cas de diabète traité, grossesse, TCA, adolescence.
- **ANSES (2010)** : les pratiques alimentaires d'amaigrissement exposent à des déséquilibres et à la reprise de poids.
- **Ramadan** : pas de prise du lever au coucher du soleil ; exemptions (malades, femmes enceintes, enfants, voyageurs) ; diabétiques → avis médical (**IDF-DAR, 2021**).

7. Accompagner l'évolution des pratiques (4.3.7)

Cinq principes : **comprendre** (questions ouvertes) ; **respecter** (le choix n'est pas jugé) ; **partir de l'existant** ; **préserver le plaisir** ; **sécuriser et orienter**.

Vérifier la sécurité nutritionnelle en 5 étapes : 1. décrire la pratique ; 2. repérer les groupes exclus ; 3. lister les nutriments à risque ; 4. évaluer le contexte (âge, grossesse, maladie, budget, signes d'alerte) ; 5. proposer des sources de remplacement ou orienter.

Distinguer **ce qui relève du choix** (végétarisme, religion, culture : on respecte) et **ce qui relève de la sécurité** (B12 du végétalien, protéines de la personne âgée : on garantit).

8. Rythmes et structure des prises (4.3.8)

- **Répartition indicative de l'énergie** : **petit-déjeuner 20-25 %**, **déjeuner 35-40 %**, **goûter 10-15 %**, **dîner 25-30 %**. Ce sont des **ordres de grandeur**, pas des normes.
- **Collation** : **prévue**, structurée, répond à une faim ≠ **grignotage** : sans faim, non prévu.
- **Collation de 10 h à l'école** : **non recommandée** si l'enfant a pris un petit-déjeuner (**AFSSA, 23 janvier 2004**) ; réservée aux enfants sans petit-déjeuner ; mieux vaut des petits-déjeuners pédagogiques.
- **Petit-déjeuner** : pas d'effet démontré sur le poids de l'adulte (**Dhurandhar 2014 ; Sievert 2019**, méta-analyse BMJ) ; **Betts 2014** ; chez l'enfant, effets favorables sur l'attention (**Adolphus 2013**). Exemple du cours : petit-déjeuner simple à **0,89 €**.
- **Chrononutrition** : liens entre horaires des prises, rythmes biologiques et santé ; le **travail posté** ou de nuit augmente le risque de surpoids : on construit avec la personne un plan de prises adapté à ses horaires (principe du

cours : **trois prises structurées sur 24 heures, calées sur le sommeil** plutôt que sur l'heure).
- **Habitudes (Lally et coll., 2010)** : un nouvel automatisme s'installe en **66 jours en moyenne (18 à 254)** : les « 21 jours » sont un mythe.

9. L'enfant (4.3.9)

- **Goûts innés** : attrait pour le **sucré, l'umami et le salé** ; **rejet initial de l'amer et de l'acide**. Les goûts s'apprennent dès la **vie fœtale** (liquide amniotique) et l'**allaitement**.
- **Frise** : 0-6 mois lait à la demande (le bébé régule seul) ; **diversification entre 4 mois révolus et 6 mois**, **allergènes compris, sans retarder** (œuf, arachide, gluten) (**HCSP 2020 ; Santé publique France 2021**) ; **pas de miel avant 1 an** (botulisme) ; 8-10 mois petits morceaux fondants ; 1-3 ans comme la famille (sans sel ajouté) ; **néophobie maximale entre 2 et 6 ans** (jusqu'à 10 ans).
- **Exposition répétée** : **8 à 15 expositions**, **sans pression ni récompense** (Birch et Marlin 1982 ; Birch 1980 et 1984). **Fisher et Birch 1999** : interdire un aliment le rend plus désirable. **Galloway 2006** : avec la pression, les enfants de 3-5 ans mangent **moins** l'aliment.
- **Partage des responsabilités (Ellyn Satter)** : **le parent décide quoi, quand, où ; l'enfant décide s'il mange et combien**. Protège la régulation et déculpabilise les parents.
- **Styles parentaux (Hughes et coll., 2005)**, selon **exigence** et **sensibilité** : **démocratique** (élevée / élevée, le plus favorable) ; **autoritaire** (élevée / faible, pression) ; **permissif** (faible / élevée, plus de produits sucrés) ; **désengagé** (faible / faible).
- Ne pas obliger à **finir son assiette** : habitue à ignorer le rassasiement (externalité) ; servir petit et permettre de se resservir.

10. Les âges de la vie (4.3.10)

- **Adulte** : contraintes de temps, **charge mentale alimentaire** (penser, prévoir, acheter, cuisiner), souvent portée par les femmes.
- **Adolescent** : autonomie, image de soi, pairs ; repas sautés, boissons sucrées, risque de TCA ; besoins en **calcium ≈ 1 150 mg/j** (ANSES, 2021).
- **Grossesse** : envies, nausées, **pica** (envie de substances non alimentaires) ; vigilance listériose, toxoplasmose.
- **Étudiant** : budget, équipement, isolement, réseaux sociaux.
- **Personne âgée** : baisse du goût et surtout de l'**odorat**, appétit réduit, isolement, problèmes dentaires, **dysphagie** (textures **IDDSI, 8 niveaux de 0 à 7**, définies après bilan de l'orthophoniste) ; **syndrome de glissement** (repli, refus de s'alimenter : urgence médicale).
- **Dénutrition du 70 ans et plus (HAS et FFAMCO, 2021)** : au moins **1 critère phénotypique** (perte de poids **≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois** ; **IMC < 22** ; sarcopénie) **et 1 critère étiologique** (apports **réduits ≥ 50 % pendant plus d'une semaine**, absorption réduite, agression). Exemple Mme D. : perte de **5,6 %** en 1 mois → dénutrition.
- **Autisme** : sélectivité alimentaire fréquente (textures, couleurs) → approche progressive et pluridisciplinaire.
- **Facilitation sociale** : on mange plus à plusieurs → repas partagés contre la dénutrition.

11. Observer et mesurer (4.3.11)

Outil	Principe	Limite
Rappel des 24 h	Entretien sur la veille, méthode en **5 passages**	Mémoire ; un seul jour ; sous-déclaration (seuil de **Goldberg 1991**, rapport apports / métabolisme de base ≈ **1,2**)
Carnet alimentaire	Noter tout sur plusieurs jours	Modifie le comportement, lourd
Questionnaire de fréquence	Fréquence habituelle par aliment	Imprécis sur les quantités
Observation directe	**Grille** (ambiance, durée, rôle des adultes), **accord inter-observateurs**	Ne dit pas pourquoi
Pesée des restes (plate waste)	Masse servie − masse restante	Ne dit pas qui mange quoi

Questionnaires de style alimentaire : **TFEQ, DEBQ**. **Biais** : mémoire, **désirabilité sociale**, effet de l'observateur. On combine un outil **déclaratif** et un outil d'**observation**.

12. Vers une alimentation durable (4.3.12)

- **Définition (FAO, 2010 ; publiée 2012)** : alimentation qui protège la **santé** et l'**environnement**, **accessible et économiquement juste**, **culturellement acceptable** : **4 dimensions** à tenir ensemble.
- **EAT-Lancet (Willett, 2019 ; mise à jour Rockström, octobre 2025)** : régime de santé planétaire ≈ **14 g de viande rouge par jour**, ≈ 75 g de légumineuses, ≈ 300 g de légumes.
- **Agribalyse (ADEME)**, par portion : **bœuf ≈ 2,8 kg CO2e**, volaille ≈ 0,6, œufs ≈ 0,3, **lentilles ≈ 0,06** → bœuf ≈ **50 fois** les lentilles (2,8 / 0,06 = 46,7). Message central de la **SNANC 2025-2030**.
- **Loi EGalim (loi 2018-938)** : en restauration collective, **50 % de produits durables et de qualité dont 20 % de bio** depuis le **1er janvier 2022** ; **menu végétarien hebdomadaire** en restauration scolaire, rendu **pérenne par la loi Climat et résilience (22 août 2021)**.
- **Gaspillage** : en **2023**, **9,7 Mt** de déchets alimentaires dont **3,8 Mt comestibles** (≈ **55 kg par habitant**), surtout chez les ménages (**SDES, 30 octobre 2025**). **Loi Garot 2016** (don des invendus), EGalim 2018, **loi AGEC 2020**. **DLC** « à consommer jusqu'au » (ne pas dépasser) ≠ **DDM** « de préférence avant » (consommable après).
- **Leviers de comportement** : nudges dans les selfs (**Garnett 2019** : doubler l'offre végétarienne augmente son choix ; **Bacon et Krpan 2018** : option végétarienne par défaut). Exemple : dahl de lentilles pas cher et peu émetteur.
- **Saisonnalité** : tableau des légumes et fruits de saison pour construire les menus.

13. Les TCA : comprendre, prévenir, orienter (4.3.13)

- **Prévalences vie entière (Hudson 2007)** : **anorexie 0,9 % des femmes / 0,3 % des hommes** ; **boulimie 1,5 % / 0,5 %** ; **hyperphagie boulimique 3,5 % / 2 %**.
- **Recommandations HAS** : **anorexie mentale 2010** ; **boulimie et hyperphagie boulimique 2019**.
- **Facteurs de risque** : normes de minceur, régimes, sports à catégorie de poids ou esthétiques, moqueries, perfectionnisme. **Facteurs protecteurs** : repas familiaux, estime de soi, messages **sans poids**.
- **Signes d'alerte** : **physiques** (perte de poids rapide, cassure de courbe, malaises, arrêt des règles) ; **alimentaires** (restriction sévère, évitement de familles d'aliments, crises, vomissements, laxatifs) ; **comportementaux** (sport compulsif, isolement aux repas, rituels, pesées fréquentes) ; **psychologiques** (peur intense de grossir, perception déformée du corps).
- **Réagir en 5 étapes** : 1. jamais devant le groupe ; 2. exprimer son inquiétude avec des **faits**, sans parler de poids ; 3. écouter sans convaincre ni donner de régime ; 4. **orienter** (infirmière, médecin scolaire, médecin traitant, **FFAB**) et informer les parents d'un mineur avec l'infirmière ; 5. **secret partagé** avec les seuls professionnels concernés.
- **SCOFF** (5 questions) : outil de repérage **individuel** réservé aux soignants, **jamais en atelier collectif**.
- **Orthorexie** (Bratman, 1997) : **pas un diagnostic du DSM-5**. **Dysmorphie musculaire** (« bigorexie ») : trouble de l'image du corps, surtout chez les jeunes hommes.
- **Rôle du diététicien en santé publique** : **repérer et orienter, jamais diagnostiquer**.

14. Précarité (4.3.14)

Les personnes précaires **ne mangent pas mal par ignorance** : elles ont des **stratégies** face à des contraintes fortes.

1. **Réduire la qualité pour garder la quantité** (aliments denses, bon marché ; moins de fruits, légumes, poisson).
2. **Prioriser les enfants** (les mères sautent des repas).
3. **Faire durer** (achats au jour le jour, plats qui « tiennent au corps », promotions).
4. **Recourir à l'aide alimentaire** (épiceries solidaires, colis, restaurants sociaux ; parfois honte).
5. **Préserver des moments de plaisir** (besoin de normalité et de dignité).

- **Densité énergétique et coût (Drewnowski et Darmon, 2005)** : les aliments denses donnent les **calories les moins chères**.
- **Coût de 10 g de protéines** (exemple du cours) : lentilles ≈ **0,10 €**, poulet ≈ **0,37 €**.
- **Construire un budget** (exemple du cours) : 79,35 € par semaine pour 4, soit **2,83 € par personne et par jour**, dont 28,6 % pour fruits et légumes.
- **Aide alimentaire** : **Restos du Cœur (1985)** ; PEAD → FEAD → **FSE+** ; programme **« Mieux manger pour tous » (depuis 2023)** pour des produits de qualité.
- **Action** : partir des stratégies, **reconnaître les compétences**, ne pas culpabiliser.

15. Pratiques religieuses (4.3.15)

Religion	Règles principales	Adaptation en atelier
Islam	Pas de porc ni alcool (y compris en cuisine) ; viande **halal** ; jeûne du **Ramadan** de l'aube au coucher du soleil, puis Aïd	Sans porc ni alcool, vérifier **gélatine, arômes** ; viande halal ou **plat végétarien** ; horaires adaptés
Judaïsme	**Cacheroute** : animaux autorisés seulement, pas de porc ni fruits de mer ; **séparation lait / viande** ; viande casher ; jeûne de Kippour (≈ 25 h), Pessah (pas de pain levé)	Plat lacté sans viande ou végétarien ; ustensiles à discuter
Christianisme	Abstinence de viande le vendredi (surtout pendant le Carême) ; jeûnes orthodoxes	Respect du calendrier
Hindouisme	Pas de bœuf (respect de la vache) ; végétarisme fréquent ; parfois sans œufs, ail, oignon	Plat végétarien
Bouddhisme	Souvent végétarien	Plat végétarien

- **Laïcité** : n'**oblige pas** à proposer des menus confessionnels, **mais ne l'interdit pas** ; beaucoup de communes proposent un plat de substitution ou une option végétarienne.
- **On demande, on ne suppose pas** à partir de l'origine (fiche O4.1, données protégées par le RGPD).
- **Calcul du Ramadan** : année lunaire ≈ 354,4 jours → décalage **≈ 11 jours par an**. Début vers le **18 février 2026**, vers le **7-8 février 2027** ; **deux Ramadans en 2030**. Durée du jeûne en France : ≈ 12-13 h en février, **17-19 h** en été.
- **Conseils** : repas de rupture (dattes, eau, soupe, plat complet), repas avant l'aube, **hydratation** la nuit ; répartition de l'énergie sur la nuit.

16. Dégustation et analyse sensorielle (4.3.16)

- **Échelle hédonique** (smileys de 1 à 5) ; **taux d'acceptation** = nombre de notes 4 et 5 / nombre de participants × 100.
- **Test triangulaire (ISO 4120)** : 3 échantillons, dont 2 identiques ; trouver l'intrus. Hasard = **1 chance sur 3 (33,3 %)**. Avec 24 dégustateurs, il faut **au moins 13 bonnes réponses** pour conclure à une différence (seuil 5 %).
- **Flaveur** = saveurs (langue) + **arômes (rétro-olfaction)** + texture + température + sensations trigéminales. La « carte de la langue » est **fausse**. Avec le nez pincé, on distingue mal pomme et poire.
- **Goûteurs / non-goûteurs / super-goûteurs** (PTC, PROP ; gène **TAS2R38** ; **Bartoshuk**, années 1990) : un enfant qui refuse les endives perçoit peut-être une amertume réelle.

17. Cultures culinaires et fil rouge (4.3.17 à 4.3.19)

- **Cultures culinaires** : repères sur les cuisines du Maghreb, d'Afrique de l'Ouest, d'Asie, etc. Adapter **sans dénaturer** : garder le **nom, le goût et la fonction sociale** du plat, ajuster avec la personne (huile, sel, viande, légumes), ex. **mafé** avec moins d'huile et plus de légumes.
- **Fil rouge, centre social des Tilleuls (Inès)** : plats copieux et conviviaux ; **7 familles sur 12 mangent halal** (recettes sans porc ni alcool, atelier hors Ramadan) ; échelle de la faim à l'atelier goûters ; recettes du monde (tiep, chorba, dal) avec légumes de saison ; recettes « aussi rapides qu'une livraison » (< 20 min) ; **43,8 %** (21/48) des enfants sans petit-déjeuner au moins 2 jours ; petit-déjeuner rapide à **0,55 €** ; légume découverte : **36 % → 72 %** des enfants goûtent (8 semaines) ; **parmentier de lentilles 0,68 €** (≈ 0,04 kg CO2e) contre ≈ 1,20 € au bœuf (≈ 2 kg CO2e) ; slogan « bon pour la santé, le porte-monnaie et la planète ».
- **Six cas guidés** : « Manger sans culpabilité » en association de quartier ; goûter de l'accueil périscolaire ; restaurant d'un ESAT ; internes d'un lycée agricole ; achats d'une épicerie solidaire ; réunion de parents en PMI (Satter et styles parentaux).

18. Approfondissements (4.4 et 4.5)

- **Approches non restrictives** : **alimentation intuitive (Tribole et Resch, 1995)**, **GROS** (Apfeldorfer, Zermati), **pleine conscience** : réhabiliter faim, rassasiement et plaisir plutôt que prescrire un régime.
- **Dimension sociale** : repas familiaux réguliers = meilleure alimentation de l'enfant ; isolement = **risque de dénutrition**.
- **NOVA (Monteiro, Brésil)**, **4 groupes** selon le **degré de transformation** : 1. bruts ou peu transformés ; 2. ingrédients culinaires (huile, beurre, sucre, sel) ; 3. transformés (pain de boulangerie, fromages, conserves) ; 4. **ultra-transformés** (arômes, émulsifiants, édulcorants, protéines isolées). Associations avec obésité, maladies cardiovasculaires, diabète, mortalité (NutriNet-Santé), **causalité discutée**. NOVA **complète** le Nutri-Score (qualité nutritionnelle), elle ne le remplace pas.
- **Dégoût (Rozin et Fallon, 1987)** : rejet lié à l'**origine ou à l'idée** de l'aliment, on refuse même de goûter ≠ « je n'aime pas ». ≈ **2 milliards** de personnes mangent des insectes (FAO, 2013).
- **Insectes** : « nouveaux aliments » (règlement UE **2015/2283**), autorisés : ténébrion meunier séché et criquet migrateur (**2021**), grillon domestique (**2022**), petit ténébrion (**2023**) ; risque d'**allergie croisée** avec crustacés et acariens. Dégustation **volontaire, jamais imposée**.
- **Substituts végétaux** : les décrets français de 2022 et 2024 sur les dénominations ont été **annulés** après l'arrêt de la **CJUE du 4 octobre 2024** ; un règlement européen réservant « steak », « bacon », « foie » aux produits carnés a été **voté par le Parlement européen le 16 juin 2026** et attendait l'accord des États. Une galette végétale (Ciqual 2025) apporte **1,3 g de sel / 100 g** (13 fois la viande crue, 26 % des 5 g de l'OMS) : pas « meilleure » par nature ; les **légumineuses cuisinées** restent le meilleur choix santé et budget.
- **Neuro-hormonal (L3)** : hypothalamus, neurones **NPY/AgRP** (orexigènes, ghréline) et **POMC/CART** (anorexigènes, leptine, insuline) ; **résistance à la leptine** dans l'obésité ; **analogues du GLP-1** (sémaglutide) : satiété, vidange gastrique, risque de perte musculaire → accompagnement diététique.
- **« Aimer » et « vouloir » (Berridge)** : **liking** (plaisir, opioïdes) ≠ **wanting** (désir, **dopamine**, déclenché par des indices) ; c'est le désir qui s'emballe.
- **Hyperpalatabilité (Fazzino, 2019)** : gras + sodium, gras + sucres, glucides + sodium ; ≈ 62 % d'une base américaine. Décrit une **offre**, pas un mangeur.
- **Mangeur pluriel** : pratiques qui changent selon le contexte. **Profils alimentaires (Hu, 2002)** : a priori (score) ou a posteriori (ACP) ; profils « prudent » et « occidental » ; association, pas causalité.

19. Préparer l'épreuve (4.6)

- **Lire un contexte imposé en 6 questions** : 1. **âge et stade** ; 2. **rôles** de l'acte alimentaire ; 3. **pratiques** (religions, végétarisme, allergies) ; 4. **déterminants** (budget, temps, équipement, compétences) ; 5. **régulations et dérégulations** ; 6. **évaluation** (échelle hédonique, question ouverte).
- **Exemple foyer ASE** : pizza maison **sans porc pour tous** (personne n'est mis à part), autonomie des jeunes, coût **1,79 € par jeune** (14,35 € pour 8) contre 10-15 € une pizza livrée ; message plaisir, rapidité, coût, **pas de poids**.
- **Réponse orale en 3 temps** : **définir, illustrer, justifier** (avec une source datée).
- **Questions fréquentes** : « Pourquoi ne pas parler de poids ? » (restriction cognitive, stigmatisation, TCA) ; « Pas le temps de cuisiner ? » (recettes < 20 min, surgelés, conserves) ; « Recette acceptée ? » (taux d'acceptation) ; « Vos chiffres ? » (source, année, méthode ; dire quand c'est **fictif**).
- **Situations professionnelles** : BC1 restriction en consultation ; BC2 menus et pratiques des convives (EGalim, Ramadan en foyer) ; BC2 collation à l'école ; BC3 atelier « faim et envie », jeunes végétariens, ateliers durables.

20. Fiches-outils du chapitre

Outil	Contenu	À quoi il sert
O4.1	Recueil des pratiques d'un groupe (sans porc / halal, casher, végétarien, végétalien, jeûne, allergies, intolérances, textures)	Adapter l'action ; **accord** des personnes ; données de santé protégées (**RGPD**)
O4.2	Échelle de la faim et de la satiété (0 à 10)	Atelier sensations, enfants et adultes

Outil	Contenu	À quoi il sert
O4.3	Grille d'analyse d'un comportement (quoi, quand, combien, où, avec qui ; rôles ; régulation ; dérégulations ; déterminants ; leviers ; signes d'alerte)	Analyser un cas
O4.4	Compatibilité d'une recette (sans porc, végétarien, végétalien, sans gluten, sans lait, allergènes)	Choisir des recettes communes
O4.5	Repérage et orientation	Conduite à tenir en collectif

21. Chiffres et dates à savoir

Repère	Valeur
UNESCO repas gastronomique	**2010**
Herman et Polivy (restriction cognitive)	**1975**
Schachter (externalité)	**1968**
Holt (indice de satiété)	**1995** : pomme de terre 323, croissant 47
Alimentation dans la consommation	**35 % (1960) → 20 % (2014)** ; 12,5 % en 2025 (sens strict)
Sans viande / flexitariens / limitent	**2 % / 24 % / 8 %** (2020)
Répartition énergie	**20-25 / 35-40 / 10-15 / 25-30 %**
Diversification	**4 à 6 mois**, allergènes sans retard
Néophobie / expositions	**2-6 ans** / **8 à 15**
Habitude	**66 jours** (18 à 254)
Dénutrition 70 ans et plus	**HAS-FFAMCO 2021** ; −5 % en 1 mois, −10 % en 6 mois, IMC < 22
EAT-Lancet	**2019**, mise à jour **2025** ; 14 g/j viande rouge
Bœuf / lentilles	**2,8 / 0,06 kg CO2e** par portion
EGalim	**50 % dont 20 % bio** (1er janvier 2022)
Gaspillage 2023	**3,8 Mt** comestibles, ≈ 55 kg/hab. (SDES 2025)
TCA (femmes)	AN **0,9 %**, BN **1,5 %**, BED **3,5 %**
HAS TCA	AN **2010**, BN et BED **2019**
Collation à 10 h	AFSSA **2004** : non si petit-déjeuner
Distributeurs payants en milieu scolaire	**Interdits depuis 2005** (loi du 9 août 2004)

22. Les pièges

- Confondre **rassasiement** (pendant) et **satiété** (après).
- Dire que la dopamine est une hormone.
- Prescrire ou encourager un **régime restrictif** en santé publique ; parler de **poids** en atelier.
- Classer des aliments en « **interdits** » (l'interdit augmente l'attrait).
- **Juger** une pratique (végétarisme, religion) au lieu de la **sécuriser**.
- Supposer une pratique religieuse à partir de l'origine.
- **Poser un diagnostic de TCA**, utiliser le SCOFF en groupe.
- Forcer, récompenser ou punir un enfant pour qu'il goûte ; « finis ton assiette ».
- Retarder les allergènes ; donner du miel avant 1 an.
- Confondre **NOVA** (transformation) et **Nutri-Score** (qualité nutritionnelle) ; **DLC** et **DDM**.
- Croire qu'une galette végétale est forcément « meilleure » qu'un plat de lentilles.
- Utiliser l'âge de la retraite pour définir la personne âgée.